中醫服藥護理

一、中藥的基本分類

（一）中藥的基本藥性分類－寒、熱、溫、涼四種。如天冷受寒感冒用熱性的薑母湯，皮膚生瘡用寒性的黃連，關節寒痛用溫性的桂枝，口渴多喝涼性的菊花茶。

（二）中藥基本藥味分類－辛、甘、酸、苦、鹹。辛味如紫蘇、薄荷，善於發汗行氣；甘味如黨參、枸杞，善於補益滋養；酸味如石榴皮，善於收斂固澀；苦味如黃連、黃柏，有瀉下、瀉火功能；鹹味如牡蠣、海藻，有通便、軟堅散結作用。

二、中藥服用的方法

（一）內服的劑型分為－湯劑、丸劑、散劑、膏劑及藥酒。

（二）湯劑的煎煮容器最好使用陶器、砂鍋、鋁鍋或不鏽鋼鍋，不可用銅、錫、鐵鍋。

（三）湯劑煎煮的水量與濃度

1.第一煎：水需超過藥物 3~5 公分，煎出濃度 70~80%。

2.第二煎：水需超過藥物 1~2 公分，煎出濃度 20~30%。

3.建議一帖藥煎煮兩次，混合使用。

（四）湯劑一般是早晚各服用一次，一天內服完，否則冷藏可保存 2~4 天，加溫後再服用。

（五）散劑（濃縮中藥粉）較方便攜帶與服用，可以開水吞服或拌服，避免嗆到，依醫師處方，分 3 次或 4 次服用。

（六）一般滋補的中藥是空腹服用；對腸胃道刺激性大的藥，如太苦寒，或活血化瘀性的中藥，可飯後服用；安神藥則在睡前服用；驅蟲藥在清晨空腹服用；嘔吐的病人應少量多次服用；調經藥於臨近經期前數日服用。

三、中藥服用的注意事項

（一）中、西藥服藥時間相隔至少 1 小時。

（二）配服中藥用溫開水，不宜用茶水，因茶中的鞣酸很容易和許多中藥之有效成分的生物鹼結合，產生沉澱；然而茶鹼與咖啡鹼有強心、利尿、興奮中樞神經等作用，會影響鎮靜安眠藥物的療效。

（三）服解表藥（感冒藥）、透疹藥（抗過敏藥）應少食生冷及酸味食物。酸味藥（山楂、酸棗仁、山茱萸、吳茱萸）具收斂作用，會使藥效降低。

三軍總醫院　護理部　中醫部　編印

諮詢電話：(02)87927056

46-CMC-11（2015.06 醫療紀錄管理委員會審核通過、2017.06 修、2019.03 修）

（四）服清熱涼血及滋陰藥時，不宜吃辛辣食物。辛辣食物屬熱性，會抵消清熱涼血藥之作用。

（五）湯劑藥物不宜與食物一同進食，以避免互相影響，因此一般湯藥宜在飯後半小時服用。

（六）孕婦禁忌使用的中藥－毒性很強的斑蝥、巴豆；瀉下藥如大黃、芒硝；活血化瘀藥如紅花、桃仁、麝香；行氣破滯藥如枳實；大辛大熱的附子、肉桂，都可能傷及胎兒或引起流產，另外常見的牛黃、薏苡仁也宜慎用。

（七）正確按時依醫囑服藥，以利維持血中藥物濃度。

（八）若同時至西醫就診，亦請告知醫師您有服用中(西)藥，並將處方提供給醫師做為診治的參考。

（九）藥粉若出現結塊，並不是壞掉而是受潮的緣故，不影響療效，建議應將藥包放進夾鍊袋內將袋口封緊，且要留意藥物的有效期限或變質、變色的藥物應停止使用，存放時貯存在乾燥陰涼的地方，避免熱與陽光，才不會影響藥效。

參考資料

吳孟霖、陳俞沛、黃書澐（2016）・淺談中藥用藥安全及中、西藥交互作用・*醫學暨老年學雜誌，11*（1），1-15。

杜穎純（2018）・濃縮中藥與水藥的差別・*消費者報導雜誌，451*，21-25。

林宗輝、洪奇楠、李官樺、劉云、廖美芬（2015）・大學生中藥用藥安全認知之研究・*休閒保健期刊，14*，167-175。

護理指導評值

1. （　）　中藥與西藥的服用時間需相隔至少一個小時
2. （　）　湯劑若冷藏後需加溫過後才服用
3. （　）　湯劑不可以跟食物一起進食，避免互相影響
4. （　）　以下何種容器不可用來煎煮湯劑？
   (1)陶器；(2)砂鍋；(3)不鏽鋼鍋；(4)鐵鍋
5. （　）　服用藥物注意事項，以下何者錯誤？
   (1)服藥時需佐配溫開水，不可茶水；(2)按時依醫囑服藥，以維持血中藥物濃度；(3)至西醫就診時，不需告知有服用中藥；(4)若藥

物有變質或變色應停止服用此藥物

6. （　） 服藥的時間點，何者錯誤？

(1)滋補的中藥是空腹服用；(2)對腸胃道刺激性大的藥可飯後服用；(3)安神藥則在睡前服用；(4)驅蟲藥在清晨飯後服用

（答對 5-6 題⇨完全了解；答對 3-4 題⇨部分了解；答對 1-2 題⇨完全不瞭解）

1.（O） 2.（O） 3.（O） 4.（4） 5.（3） 6.（4）

三軍總醫院　護理部 中醫部　編印
諮詢電話：(02)87927056